

Insuficiência Cardíaca

O essencial no idoso

Apresentado por: Dr Igor Cruz Morais

20 minutos



Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deve conseguir...

- Reconhecer IC no idoso (inclusive apresentações atípicas).
- Classificar por estágio (A–D), classe funcional (NYHA) e fração de ejeção.
- Solicitar exames certos no tempo certo (NP + eco) e interpretar “alto vs. baixo”.
- Iniciar tratamento baseado em evidência (IC FEr e IC FEIr) e saber o que muda em IC FEp.
- Identificar sinais de gravidade, descompensação e quando encaminhar (IC avançada).

Por que IC importa no idoso?

IC no idoso é...

- Alta prevalência
- Alta hospitalização
- Alta polifarmácia
- Alta vulnerabilidade (fragilidade)

Se você dominar “o básico bem feito”, você salva internações.

Ponto-chave

No idoso, IC pode parecer
“cansaço do envelhecimento”.

Sua missão: separar normal de
patológico.

História em 60 segundos

“Dropsy” → circulação → guideline



1785 — Withering
Digitalis + “dropsy”



- Antiguidade: edema (“hidropsia”)
- 1628: circulação (Harvey)
- 1890s: RX/ECG → diagnóstico
- 1970s+: Framingham → prognóstico
- 2021–2023: Cardiol/ESC
- 2022: AHA/ACC

O que é insuficiência cardíaca?

Definição prática para a vida real

IC = síndrome clínica

Quando o coração não consegue atender às demandas do corpo
OU só consegue às custas de pressões de enchimento elevadas.

→ Resultado: sintomas (dispneia/fadiga) + sinais (congestão).

Duas classificações que você vai usar sempre

Estágio (A–D) e NYHA

Estágios (AHA/ACC)

- A** Risco (sem doença estrutural/sintomas)
- B** Doença estrutural/biomarcadores (sem sintomas)
- C** Sintomática (atual ou prévia)
- D** Avançada/refratária (especialista/paliativos/dispositivos)

NYHA (functional - sintomas)

- I sem limitação
- II leve
- III importante
- IV em repouso

*Regra rápida:
NYHA mede “vida diária”.*

Fenótipos por fração de ejeção (FEVE)

Isso guia tratamento e prognóstico

IC FE_r

$\leq 40\%$

IC FE_Ir

41–49%

IC FE_p

$\geq 50\%$

IC FE_m

$> 40\%$
(era $< 40\%$)

Atalho de prova: “IC FE_m” continua como IC FE_p (não suspender).

Pense em 2 problemas

Congestão vs. baixo débito

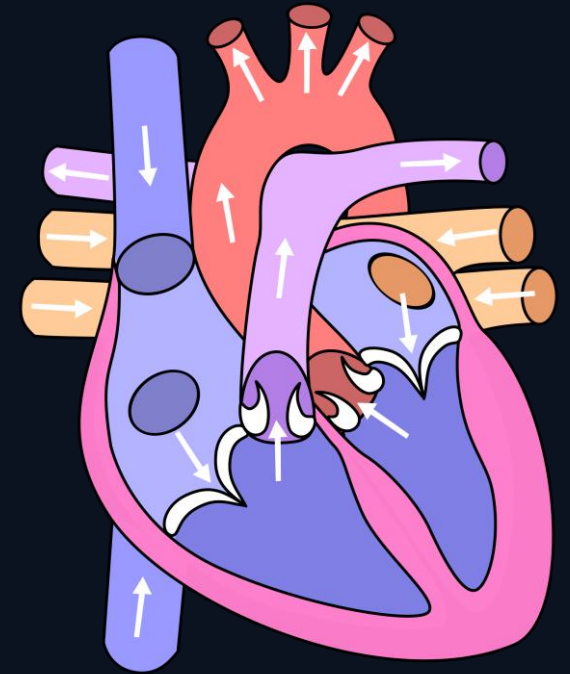
1) CONGESTÃO

Dispneia, ortopneia, edema, turgência jugular.

2) BAIXO DÉBITO

Fadiga, hipotensão, extremidades frias, confusão no idoso.

Neuro-hormonal (SNS/RAAS) mantém curto prazo → piora longo prazo.



No idoso, IC pode ser “silenciosa”

Sinais/sintomas “pista”

- queda recente de capacidade funcional
- dispneia aos esforços “menores”
- edema/ganho de peso
- delirium/confusão (especialmente na descompensação)
- intolerância a medicações usuais (hipotensão, piora renal)

Diagnóstico: 3 passos

Suspeita → NP → ecocardiograma

1

Suspeite

Sintomas/sinais + ECG
(idoso: atenção ao
“atípico”)

2

**Peptídeos
natriuréticos**

Baixo = IC improvável
Alto = apoia + estratifica

3

Ecocardiograma

FEVE + valvas + pressão
+ causas estruturais

Cut-offs úteis (ESC):

Crônica: BNP <35 ou NT-proBNP <125.

Aguda: BNP <100 ou NT-proBNP <300.

Conceito-chave: congestão é “imagem + clínica”

No RX, procure:

- cardiomegalia
- linhas B de Kerley
- redistribuição vascular
- derrame pleural

No idoso, congestão pode coexistir com DPOC/pneumonia → pense “causa dupla”.

IC FEr: a base do tratamento (4 pilares)

Começar cedo. Ajustar rápido.

ARNI/IECA/BRA

Remodelamento
↓ mortalidade

Betabloqueador

↓ SNS
↑ sobrevida

MRA

Antialdosterona
↓ eventos

iSGLT2

Benefício rápido
↓ internação

Diurético = alívio de sintomas (congestão). Não substitui os 4 pilares.

Como iniciar no idoso (sem “matar de hipotensão”)



Segurança primeiro

Antes de prescrever, cheque 3 coisas:

- 1) Pressão e sintomas de hipotensão
- 2) Função renal + potássio
- 3) Congestão (precisa diurético?)

Estratégia simples (para estudantes):

- Comece 1–2 pilares já na primeira semana (doses baixas).
- Reavalie em 1–2 semanas e “complete” os 4 pilares.
- Ajuste diurético conforme sintomas/peso.

IC FEp: o que mudou de verdade

ESC 2023: SGLT2 = Classe I (A)

1 ideia:

Em IC FEp, iSGLT2 (empagliflozina/dapagliflozina) reduz internação e sintomas.

O resto continua essencial no idoso:

- diurético para sintomas
- controle de PA
- tratar FA/DM/obesidade/apneia
- reabilitação e educação

Descompensação aguda: pense em “causa + congestão”

Primeiras decisões

3 perguntas na sala:

- 1) Está congesto?
- 2) Está mal perfundido?
- 3) Qual gatilho? (infecção, IAM, FA, falta de diurético, anemia, TEP)

Ações iniciais (resumo):

- Oxigênio/ventilação se necessário
- Diurético IV se congesto
- Tratar gatilho (antibiótico, controle de FA, reperfusão etc.)

Tratamento “invisível” que funciona

Educação + reabilitação + vacinação

Autocuidado

peso diário
reconhecer
edema/dispneia
adesão

Reabilitação

exercício
supervisionado
força/balanço
queda ↓

Vacinas

influenza
pneumococo
COVID-19 conforme
CNV.

Sódio/fluido

individualizar
evitar extremos

Dispositivos: quando lembrar (IC FEr)

ICD / CRT (visão de estudante)

Pense em dispositivo quando:

- IC FEr persistente apesar de terapia otimizada
- QRS largo + sintomas → Ressincronizador
- Alto risco de morte súbita → CDI

No idoso: decisão é “benefício vs. fragilidade vs. preferência”.

O “plus” da geriatria na IC

Checklist do dia a dia:

- fragilidade e risco de quedas
- polifarmácia (interações / adesão)
- hipotensão ortostática
- DRC/hipercalcemia
- anemia/ferropenia
- amiloidose (idoso + IC FEp + hipertrofia)



Caso (2 minutos)

Você decide o próximo passo

Homem, 78 anos, HAS/DM.
“Cansaço” há 2 meses, piora em 1 semana.
Edema MMII, ortopneia, crepitações bibasais.
PA 106/62, FC 98, SatO₂ 93%.

*Resposta esperada: D
(Suspeita → BNP → Eco)*

Pergunta:

Qual é o melhor “próximo passo” para confirmar IC e guiar conduta?

- A) RX
- B) BNP/NT-proBNP
- C) Eco
- D) Todos (na ordem certa)

Take-home messages

3 frases para levar para a vida

- 1) IC no idoso pode ser atípica → suspeite cedo.
- 2) Diagnóstico = NT P BNP + eco; congestão = clínica + imagem.
- 3) IC FEr: 4 pilares; IC FEp: iSGLT2 + controle de comorbidades.

Bibliografia/Leitura essencial:

- HEIDENREICH, P. A. et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure. *Circulation*, v. 145, n. 18, p. e895–e1032, 2022. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001063.
- MCDONAGH, T. A. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, v. 42, n. 36, p. 3599–3726, 2021. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab368.
- MCDONAGH, T. A. et al. 2023 Focused update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, v. 44, n. 37, p. 3627–3639, 2023. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad195.
- MARCONDES-BRAGA, F. G. et al. Atualização de tópicos emergentes da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca – 2021. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 116, n. 6, p. 1174–1212, 2021. DOI: 10.36660/abc.20210367.